

最期の場所が「希望通り」であること

— 患者さんご家族にとっての意味 —

患者さんにとって

「自分で選んだ場所で最期を迎えられた」
という安心感

ご家族にとって

「約束を守れた」という心の支え。
逆に不一致は後悔につながることも

あなたが関わった患者さん・利用者さんは、
希望通りの場所で最期を迎えられましたか？

今日の学習目標

1

自分の職種の役割

場の移行（トランジション）で
自分の職種が何をできるか説明できる

2

家族支援

ご家族への支援アプローチを
3つ挙げられる

3

急変時の連携

急変が起きたとき、
自分がとるべき行動を理解する

すべての職種に関係するテーマです

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは？

「これからのことを、本人・ご家族・私たちで一緒に話し合い続けること」

一度決めたら終わりではなく、状況が変わるたびに何度でも話し合う

「人生会議」という愛称でも知られている

紙に書くことより、対話のプロセスそのものが大切

患者さんの気持ちは変わることがある。だからこそ「繰り返し」が重要

研究が教えてくれたこと — 100 人の患者さんがいたら

緩和ケア病棟から自宅に退院した患者さん 359 人の遺族への調査（2018 年）

自宅で亡くなった方

80 人

100 人中、希望通り

緩和ケア病棟で亡くなった方

82 人

100 人中、希望通り

でも裏を返すと… 100 人のうち約 20 人は、希望と違う場所で亡くなっています。
しかもこれは最も手厚い支援を受けた方たちの数字です。

なぜ「希望通り」にならないのか

痛みの管理が難しかった

在宅では 24 時間の対応が難しい場面がある

在宅で対応できる医師がいなかった

地域によって医師の数に大きな差がある

ご家族の介護負担が限界を超えた

「見ていられない」という心理的つらさも

逆のケースも：在宅医療に対応してくれる医師・看護師が見つかり、
「病棟の予定だったけど自宅で看取れた」というポジティブな変化もある

あなたの職種でできること（１）

看護師

退院前カンファレンスでの情報引き継ぎ
症状変化の早期発見と医師への報告
ご家族への症状管理の教育

SW / 医療相談員

在宅サービスの調整
ご家族の経済的・社会的不安への対応
バックアップベッドの事前確保

ケアマネジャー

介護サービスの迅速な調整
ご家族のレスパイト支援の計画
在宅チーム全体の連携の要

あなたの職種でできること（2）

薬剤師

レスキュー薬の事前配置と使い方の説明
服薬管理のサポート
医師との薬剤調整の橋渡し

介護職

日々のケアの中での「いつもと違う」の気づき
1日8～16時間一緒にいるからこそ見える変化
あなたの「気づき」が医療チームへの大切な情報に

介護職への緩和ケア教育は全国で約10%の施設でしか行われていない。
でも、最も長い時間を患者さんと過ごすのはあなたです。

ご家族への声かけ — 明日から使える 3 つのアプローチ

不安を受け止める

「夜、ひとりで見ているのは不安ですね。
何かあったらいつでも連絡してください」
「がんばりすぎていませんか？ あなたの体も大切です」

急変時に備える

「もし急に痛みが強くなったら、まずこのお薬を使ってください。そのあと〇〇に電話してください」
「夜間の連絡先はここに貼っておきますね」

心の準備を支える

「ご本人の希望を、改めて確認しておきましょうか」
「今のお気持ちを聞かせていただけますか？」
「何でも大丈夫ですよ」

グループワーク（5分）「自分の職種でできること」

緩和ケア病棟から自宅に戻った患者さんが、
希望通りの場所で最期を迎えるために、
あなたの職種でできることは何ですか？

考えるヒント

退院前にできること

退院直後にできること

在宅療養中にできること

急変時にできること

正解はありません。「自分ならこうする」を考えてみてください。

今日から始める、あなたのアクション

職種	明日からの 1 アクション
看護師	退院前カンファレンスで「急変時の連絡先」を必ず確認する
介護職	「いつもと違う」を感じたら、その日のうちに看護師に伝える
SW / 相談員	バックアップベッドの確保状況を退院前にチェックする
ケアマネ	家族のレスパイトニーズを月 1 回は確認する
薬剤師	レスキュー薬の配置と使い方を家族に説明する

「自分には関係ない」 → 「自分にもできることがある」